

BDD u młodzieży

BDD często zaczyna się w okresie dojrzewania (12–18 lat). U młodzieży obraz jest specyficzny: większa rola rówieśników, mediów społecznościowych, ryzyko samobójcze i potrzeba zaangażowania rodziców.

CZAS: 20 min — przeczytanie Dla rodziców, terapeutów, młodzieży

ŹRÓDŁO: Greenberg (2010); Krebs (2017); Wilhelm (2013)

JAK UŻYWAĆ

BDD u młodzieży to *poważne, ale dobrze rokujące zaburzenie*, jeśli zostanie rozpoznane wcześnie. Średni wiek zachorowania: **16,4 lat** (Phillips 2005); 70% przypadków zaczyna się przed 18 r.ż. Mimo to *diagnoza najczęściej spada na lata 20.* — bo objawy są mylone z „nastoletnią niepewnością”, a nastolatek wstydzi się ujawnić. Obraz BDD u młodzieży *różni się* od dorosłego: większy wpływ rówieśników, mediów społecznościowych, częściej współistniejące zaburzenia odżywiania, większa rola rodziny w obrazie i terapii.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Greenberg i wsp. (2010): „BDD u młodzieży jest *niedoceniane*. Większość *pediatrów nie pyta o objawy BDD; rodzice nie wiedzą, że to zaburzenie*”. Krebs i wsp. (2017, RCT z 30 nastolatkami): CBT dostosowane daje **50% remisji po 14 sesjach**, porównywalnie do dorosłych — pod warunkiem zaangażowania rodzica. Konsekwencje praktyczne: **1)** nie ignoruj kompulsji (lustro >1h/dzień, unikanie szkoły z powodu wyglądu, prośby o operacje); **2)** ryzyko samobójcze *najwyższe* — 80% myśli, 22% prób (Phillips 2007); **3)** terapia *powinna* angażować rodzica (Family Accommodation Scale-BDD); **4)** SSRI skuteczne, ale wymagają monitoringu; **5)** redukcja mediów społecznościowych — szczególnie Instagram, TikTok — silnie wskazana.

01 = Czerwone flagi — kiedy to nie zwykła nastoletnia niepewność

CZAS PRZED LUSTREM

Nastolatek poświęca >1 h dziennie sprawdzaniu wyglądu. Spóźnienia do szkoły, opuszczanie posiłków.

UNIKANIE SZKOŁY / AKTYWNOŚCI

Opuszczanie lekcji z powodu wyglądu, odmowa wyjścia z domu, rezygnacja z hobby, sportu, znajomych.

PROŚBY O ZABIEGI

Powtarzające się prośby o operacje plastyczne, wybielanie zębów, korekty dermatologiczne u nastolatka.

PYTANIA O ZAPEWNIENIE

Wielokrotne, codzienne pytania: „czy widać?”, „czy jestem brzydki/-a?”. Nawet po zapewnieniu — niewiara.

ZDJĘCIA W SIECI

Setki selfie dziennie, godziny edytowania, niemożliwość udostępnienia bez modyfikacji. Lub odwrotnie — całkowite unikanie zdjęć. Wzmianki o samobójstwie — natychmiastowa konsultacja.

02 ● Media społecznościowe — paliwo dla BDD

Instagram, TikTok, Snapchat mają *specyficzny wpływ* na BDD u młodzieży (Fardouly & Rapee 2019):

Filtry urody. Twarz z filtrem staje się „punktem odniesienia” — nastolatek porównuje swoją *realną* twarz z filtrowaną. Powstaje „*Snapchat dysmorphia*” — chęć modyfikacji twarzy do filtra.

Algorytmiczna ekspozycja. Algorytm „uczy się”, że nastolatek ogląda treści o ciele — i pokazuje ich coraz więcej. Tysiące zdjęć dziennie; mózg adolescentny nie ma jeszcze dojrzałych mechanizmów porównań.

✓ CO POMAGA

- Słuchać bez oceniania
- Mówić wprost: „widzę, że cierpisz”
- Konsultacja ze specjalistą BDD
- Nie dawać zapewnień („nie widać tego”)
- Nie pozwalać na operacje plastyczne
- Ograniczyć media społecznościowe
- Wspierać terapię CBT (Wilhelm)

✗ CO SZKODZI

- Bagatelizowanie („nic ci nie jest”)
- Zapewnienia („jesteś piękna/-y”)
- Krytykowanie wyglądu
- Zgoda na zabiegi kosmetyczne
- Karanie za sprawdzanie w lustrze
- Ignorowanie sygnałów samobójczych
- Wyłączny nacisk: „przestań”

FAMILY ACCOMMODATION

Rodzina *mimowolnie* wzmacnia BDD: daje zapewnienia, dopasowuje się do rytuałów (czeka, aż dziecko skończy sprawdzanie), kupuje kosmetyki, finansuje konsultacje. To *zrozumiałe*, ale *utrzymuje* zaburzenie. Terapia BDD u młodzieży zwykle uczy rodzica **jak nie wzmacniać** rytuałów, jednocześnie wspierając emocjonalnie.

✗ Ryzyko samobójcze — natychmiastowe sygnały

BDD u młodzieży ma **najwyższe wskaźniki samobójcze** wśród zaburzeń psychicznych adolescentnych: 80% myśli samobójczych, 22% prób (Phillips 2007). To wymaga *aktywnego* monitorowania.

Sygnały wymagające natychmiastowej konsultacji:

- Mówienie o samobójstwie, nawet „żartem”
- Pisanie pożegnalnych listów, post w mediach społecznościowych
- Rozdawanie rzeczy
- Nagła „pogoda ducha” po długim okresie depresji (może oznaczać decyzję)
- Wzmianki: „jak by mnie nie było, byłoby lepiej”
- Poszukiwanie metod (internet, leki)

Jak rozmawiać: nie unikaj pytania. „Czy myślisz czasem, że lepiej byłoby ci nie żyć?” — bezpośrednie pytanie *nie zwiększa* ryzyka, *zmniejsza*. Pomaga nastolatkowi powiedzieć prawdę.

Telefony zaufania (PL): 116 111 (dzieci/młodzież), 116 123 (dorośli w kryzysie), 800 12 12 12 (Dziecięcy Telefon Zaufania RPD).

Mapa wsparcia — dla rodzica

1. Specjalista pierwszego kontaktu: psycholog lub psychiatrą dziecięco-młodzieżowy znający BDD

2. Terapia CBT dla BDD u młodzieży (Wilhelm/Krebs):

3. Lekarz rodzinny lub psychiatrą (jeśli rozważana farmakoterapia SSRI):

4. Numery alarmowe: ☐ 116 111 (młodzież) ☐ 112 (kryzys ostry)

5. Plan na sytuację kryzysową:

Klucz: Krebs i wsp. (2017): „BDD u nastolatka jest dobrze leczalnym zaburzeniem, jeśli zostanie rozpoznane. Rok 2010 to przełom — od tego momentu mamy dowody, że CBT z zaangażowaniem rodzica daje 50% remisji w 14 sesjach. Klucz to wczesne rozpoznanie i nieignorowanie”. Im wcześniej rozpoznanie, tym lepiej rokowanie.